5 hlavných noviniek v liečbe obezity z ECO 2026

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 12.05.2026



Ilustračná scéna. Liečba obezity sa rozvetvuje — a výsledok sa skladá z viacerých samostatných pokrokov.

5 hlavných noviniek v liečbe obezity z ECO 2026

Kľúčové zistenia prezentované 12. mája 2026

ECO 2026, teda 33. Európsky kongres o obezite, sa koná v Istanbule od 12. do 15. mája 2026. Prezentovaný text sumarizuje päť významných noviniek v modernej farmakologickej liečbe obezity.

---

1. SURMOUNT-MAINTAIN

Dospelí pacienti najprv chudli počas **60 týždňov** pri liečbe liekom **Zepbound** (tirzepatid). Následne boli randomizovaní na pokračovanie v plnej dávke, zníženie dávky na 5 mg alebo prechod na placebo počas ďalších **52 týždňov**.

Zmena telesnej hmotnosti počas 112 týždňov

Priemerná percentuálna zmena oproti východiskovej hodnote

Obdobie chudnutia na liečbe Zepboundom, 0 až 60 týždňov

- **-22,1 %** v 60. týždni
  Koniec obdobia chudnutia na liečbe Zepboundom.

Udržiavacie obdobie, randomizovaná liečba, 60 až 112 týždňov

- Pokračovanie v Zepbounde v maximálnej tolerovanej dávke 10 až 15 mg: **-22,4 %**
- Zníženie dávky Zepboundu na 5 mg: **-16,6 %**

- Prechod na placebo, so záchrannou liečbou/imputáciou: **-10,1 %**
- Odhadované placebo bez záchrannej liečby: **-4,8 %**

Priemerná zmena hmotnosti počas udržiavacieho obdobia, 60 až 112 týždňov

- **Pokračovanie v Zepbounde v dávke 10 až 15 mg:** pacienti si udržali celý predchádzajúci úbytok hmotnosti.
- **Zníženie dávky Zepboundu na 5 mg:** pacienti opäť pribrali približne **12 libier**, teda asi **5,4 kg**.
- **Prechod na placebo so záchrannou liečbou/imputáciou:** pacienti opäť pribrali približne **30 libier**, teda asi **13,6 kg**.
- **Odhadované placebo bez záchrannej liečby:** pacienti opäť pribrali približne **43 libier**, teda asi **19,5 kg**.

67 % účastníkov v placebovej skupine potrebovalo záchrannú liečbu.

---

2. ATTAIN-MAINTAIN

Účastníci, ktorí predtým schudli pri liečbe liekom **Wegovy, semaglutid**, alebo **Zepbound, tirzepatid**, boli randomizovaní na prechod na perorálny liek **Foundayo, orforglipron**, alebo na placebo počas **52 týždňov**.

Wegovy → Foundayo

Obdobie chudnutia na Wegovy, 0 až 72 týždňov

- **-17,1 %** v 72. týždni
  Koniec obdobia chudnutia na liečbe Wegovy.

Udržiavacie obdobie na Foundayo, 72 až 124 týždňov

- **-15,1 %**

Zepbound → Foundayo

Obdobie chudnutia na Zepbounde, 0 až 72 týždňov

- **-22,0 %** v 72. týždni
  Koniec obdobia chudnutia na liečbe Zepboundom.

Udržiavacie obdobie na Foundayo, 72 až 124 týždňov

- **-16,8 %**

Priemerný opätovný prírastok hmotnosti počas 52 týždňov

Wegovy → Foundayo

- Opätovný prírastok približne **2 libry**, teda asi **0,9 kg**.
- Placebová skupina pribrala významne viac.

Zepbound → Foundayo

- Opätovný prírastok približne **11 libier**, teda asi **5,0 kg**.
- Placebová skupina pribrala významne viac.

Foundayo pomohol udržať väčšinu dosiahnutého úbytku hmotnosti v porovnaní s placebom v oboch skupinách.

Dizajn štúdie

Po **72 týždňoch** predchádzajúcej liečby Wegovy alebo Zepboundom boli účastníci randomizovaní na perorálny Foundayo alebo placebo počas **52 týždňov**, spolu do **124. týždňa**.

---

3. Vysokodávkový Wegovy 7,2 mg (semaglutid) – skorí respondéri

Štúdia STEP UP: Dospelí bez diabetu boli liečení semaglutidom v dávke **7,2 mg** v porovnaní s dávkou **2,4 mg** a placebom počas **72 týždňov**.

Skorí respondéri

≥15 % úbytok hmotnosti v 72. týždni

- **7,2 mg:** 27,7 %
- **2,4 mg:** 24,8 %

Skorí respondéri na dávke **7,2 mg** schudli do 72. týždňa v priemere **27,7 % telesnej hmotnosti**.

---

4. Wegovy v tabletovej forme (perorálny semaglutid 25 mg) – skorí respondéri

Štúdia OASIS 4: Dospelí bez diabetu boli liečení perorálnym semaglutidom **25 mg** alebo placebom počas **64 týždňov**.

Skorí respondéri

≥10 % úbytok hmotnosti v 64. týždni

- **Perorálny semaglutid 25 mg:** 21,6 %
- **Celková placebová skupina:** 2,7 %

Skorí respondéri na tabletovej forme Wegovy schudli v priemere **21,6 % telesnej hmotnosti** do 64. týždňa. Celková placebová skupina schudla v priemere **2,7 %**.

---

5. Údaje o telesnom zložení (semaglutid 2,4 mg a 7,2 mg)

Subanalýza štúdie STEP UP s použitím MRI vo vybranej podskupine účastníkov.

- Približne **84 % úbytku hmotnosti** pochádzalo z **tukovej hmoty**.
- **Viscerálny tuk** sa znížil o viac ako **30 %**.
- Došlo k určitej strate beztukovej hmoty, približne **10 %**, ale **svalová funkcia bola zachovaná**.
- Svalová sila hodnotená testom vstávania zo stoličky bola pred liečbou a po liečbe podobná v porovnaní s placebom.

Hlavné posolstvo

Dlhodobá liečba, flexibilita dávkovania a nové perorálne možnosti formujú budúcnosť starostlivosti o pacientov s obezitou. Tieto údaje podporujú význam personalizovaných a udržateľných stratégií, ktoré prinášajú najlepšie výsledky.

Autor obrázka/dát: Joseph Zucchi, PA-C

Zdroj: *Prezentácie z ECO 2026, 12. až 15. máj 2026, Istanbul; klinické štúdie SURMOUNT-MAINTAIN, ATTAIN-MAINTAIN, STEP UP a OASIS 4.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=5-noviniek-liebe-obezity-eco-2026 · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.